

对阿尔茨海默病患者实施家庭护理干预的效果观察

招丽嫚 谭晓雪 陈少梅

【摘要】 目的 观察家庭护理干预对阿尔茨海默病(AD)患者生活质量的影响。**方法** 随机对 50 例患者进行分组,25 例作为对照组,给予一般性药物治疗和健康指导;25 例作为观察组,除一般性药物治疗外,进行家庭护理干预(AD 疾病知识、心理护理、家庭安全护理、康复训练等)。干预前后分别采用健康状况调查问卷(SF-36)测评两组患者的生活质量。**结果** 实施干预 1 年后观察组患者干预后 SF-36 综合评分显著高于对照组和干预前(均 $P < 0.01$)。**结论** 家庭护理干预能有效提高 AD 患者的生活质量,延缓其病情的进展。

【关键词】 阿尔茨海默病 家庭护理干预 生活质量

阿尔茨海默病亦称老年性痴呆(Alzheimer's disease, AD),是发生在老年期及老年前期的一种原发性、退行性脑病,是一种持续性高级神经功能活动障碍,即无意识障碍,但其记忆、思维、分析判断、视空间辨认、情绪等方面出现障碍。目前,尚无特效治疗或逆转疾病进展的治疗药物。随着世界人口老龄化的加速和 AD 患病率的增加,老年痴呆的发病日益成为医疗和公共健康事业的沉重负担,AD 继心血管病、脑血管病和癌症之后,成为老年人健康的“第四大杀手”^[1]。本研究通过对 AD 患者进行家庭护理干预,提高患者的生活质量,延缓其病情和进展。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组 AD 患者 50 例:男 20 例,女 30 例,年龄 56~79 岁,平均(68.41±5.0)岁。文化程度:文盲 9 例,小学 17 例;随机将 50 例患者分为对照组和观察组,两组患者性别、年龄、文化程度、CDR 评定比较差异无显著性差异($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干预方式 家庭护理是以家庭为单位的整体护理模式,通过对患者家属实施健康教育,对患者生理、家庭和社会状况提出潜在的护理问题,进行护理干预^[2-3]。对照组进行常规出院指导,并解答患者和家属的疑问,出院后不进行任何护理干预。观察组除进行常规出院指导外,护士每周电话随访 1 次,每月家访 2 次,每季去社区举办健康教育讲座 1 次,并现场指导。

1.2.2 干预内容 1)疾病知识:向患者家属详细讲解 AD 的病因、症状、治疗及护理,将自制的 AD 患者健康教育手册和 AD 患者护理技巧手册发放给患者及照顾者,并耐心仔细地逐一讲解,直到患者和照顾人满意为止。2)心理护理:耐心倾听 AD 患者及照顾者存在问题,全面评估患者状况,给予鼓励,恰当地运用沟通技巧,做好心理疏导工作,动员老年人多与外界接触,与人交流,多参与社会活动,保持良好的社会互动。同时尊重老年人的意愿,让其独立去做自己力所能及的事情,以唤起患者对生活的信心,感受到自身存在的价值。另外鼓励子女多与老人沟通,加强邻居、亲戚、朋友间的相互走动,排解心中的孤独、寂寞,保持良好的心理健康水平^[4]。3)

家居安全护理:AD 患者自我保护能力差以及在情绪激惹、抑郁或意识模糊状态下可发生各种意外,如自伤、伤人、烫伤、跌倒、误吸(服)、走失等。因此,一定要严加看护、防范,所居住的家庭环境,要舒适、安静、整洁、安全,室内严禁放置危险物品,如剪刀、火柴等。在患者的衣服口袋里放一张联系卡片,上面写明患者的姓名、住址、联系电话等,以便患者迷路时方便社会或他人及时关照。4)康复训练:①日常生活能力训练:鼓励患者做一些力所能及的家务,如扫地、擦桌子。看护者尽量让患者自己多做事。如洗澡,可帮助患者调好水温,然后提醒患者做下一步动作,如脱衣裤等,若实在无法自己完成才去帮助他,以锻炼和维持自理能力,减少对他人的依赖。②记忆训练:包括回忆往事,实物定位、再激发,选一物品,如图片、旧照片、花、食品、衣物等让患者认,感觉,鼓励他们谈论与手中物品有关的经历。让他们回忆以前工作经历、癖好或消遣,通过唱歌,阅读旧杂志、报纸等激发记忆。③体育锻炼:要指导和鼓励老年人根据个体状况选择强度适当的体育运动,不但可以增强体力,而且还能够提高大脑皮质活动的强度、均衡性和灵活性,提高分析和综合能力,从而改善其认知功能。如有氧健身运动(慢跑、散步、太极拳等)和有氧健脑运动(深呼吸运动、冥想、手指操等)^[5]。

1.3 评定标准 采用健康状况问卷(SF-36)对患者进行评定^[6]。SF-36 包括躯体健康、心理健康、躯体疼痛,社会功能、躯体角色功能,情绪角色功能,精神和总体健康 8 个维度,每个维度最初得分需转化为终得分方可评估健康水平的变化^[7],8 个维度的终得分之和为综合得分,得分的高低能直接反映健康状况的好坏^[6-7]。每个维度的标准(终得分)总分为 100 分。综合得分总分为 800 分,得分越高,表示健康状况越好,生存质量越高。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 10.0 软件对数据进行检验。

2 结果

干预前、后两组患者 SF-36 评分比较,见表 1。

3 讨论

随着我国人口老龄化进程加快,现倡导健康的老年生活。由于我国照顾老人及痴呆患者的医疗保健措施缺乏,AD 患者的看护体系脆弱,家庭是 AD 患者的照顾主体^[8]。目前,许多 AD 患者和家庭照顾者缺乏对该疾病的相关知识,不能对 AD 患者带来很好的照顾,导致 AD 患者在家庭中难以得到系统的规范的康复护理,笔者通过家庭护理干预向 AD 患者

早期功能锻炼对颈髓损伤患者功能恢复的影响

金丽菊 庞少波 邓海涨

【摘要】 目的 探讨早期功能锻炼对颈髓损伤患者功能恢复的影响。**方法** 颈髓损伤患者 40 例，在患者生命体征稳定，将患者随机分为早期康复组和对照组。其中早期功能锻炼组，采用 Bobath 法和运动再学习方法相结合的方法进行训练；对照组，仅进行一次性康复指导。采用临床神经功能缺陷程度评分、简式 Fugl·Meyer 运动评分(FMA)和改良巴氏指数(MBI)在锻炼前后进行康复评价。**结果** 临床神经功能缺陷程度评分、上下肢 FMA 和 MBI 入选时两组无显著差异 ($P>0.05$)，出院时两组均较入选时明显改善 ($P<0.01$)，早期功能锻炼组较对照组改善程度更大。**结论** 早期功能锻炼可促进功能恢复，对颈髓损伤预后有良好的影响。

【关键词】 颈髓损伤 早期功能锻炼 功能恢复

颈髓损伤是一种致残率很高的疾病，近年来国内外均有关于颈髓损伤早期功能锻炼的报道^[1-2]。本文对 40 例颈髓损伤患者进行早期功能锻炼研究，旨在探讨早期功能锻炼对颈髓损伤患者功能恢复的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2005 年 10 月~2009 年 12 月在我院骨科住院治疗的颈髓损伤患者 40 例，其中男 27 例，女 13 例；年龄 29~79 岁，平均(63.43±10.28)岁。全部病例均经临床诊

作者单位：广东医学院附属医院(湛江)
邮 编 524001 收稿日期 2010-02-11

照顾者系统地讲解 AD 疾病知识、心理护理、家庭安全护理、康复训练等，采用简单化原则，秩序渐进，给予精神上的鼓励和支持，能有效提高患者的生活能力，延缓记忆力衰退，改善其社会功能和角色功能。

从表 1 结果显示，经过 1 年的家庭护理干预后观察组患

表 1 干预前后两组患者 SF-36 评分比较 (分, $\bar{x} \pm s$)				
SF-36	对照组		观察组	
	干预前	干预后	干预前	干预后
躯体健康	50.6±18.7	43.4±18.03*	48.8±23.1	57.5±31.1*△
心理健康	60.1±17.2	60.8±16.8	63.3±16.1	75.0±9.0*△
躯体疼痛	72.8±11.7	60.4±16.5*	76.6±18.5	78.0±17.1*△
社会功能	62.5±33.6	60.1±20.3	60.1±20.4	66.1±18.6*△
躯体角色功能	31.3±7.2	25.8±9.1	32.4±6.8	46.3±7.8*△
情绪角色功能	38.2±13.8	30.4±10.8	40.6±14.1	66.7±17.5*△
精力	50.3±20.4	46.1±22.7	61.2±14.7	65.2±14.8*△
总体健康	49.5±18.2	43.8±18.4	48.4±12.8	60.9±12.5*△
综合评分	415.3±140.8	370.8±132.6	431.4±126.5	524.7±128.4

注：与本组干预前比较 * $P<0.01$ ；与对照组干预后比较△ $P<0.01$ 。

参 考 文 献

[1] 盛树立.老年痴呆[M].北京:科学技术文献出版社,1995:5

[2] 林菊英.社区护理[M].北京:科学出版社,1998:29—100

[3] 战同霞,谢海,魏秀宏.护理干预对脑卒中偏瘫恢复期患者的影响[J].中国现代医生,2007,45(14):1—3

[4] 管新丽.抑郁症患者的社会支持状况及护理干预[J].护理研究,2003,17(8A):902—903

[5] 孙水英,曾惠,张群.老年人认知功能的研究进展及对策[J].护

理研究,2008,22(2A):285—287

[6] 许军,胡敏燕.健康测量量表 SF-36[J].中国行为医学科学,1999,8(2):150

[7] 王文娟.SF-36 量表在糖尿病患者生存质量测评中的应用[J].中国临床康复,2002,6(7):932

[8] 饶顺曾,陈碧霞,周治荣,等.社区痴呆患者的家庭照顾者心理状况研究[J].四川精神卫生杂志,2002,3(15):136—138